

Résumé — Les Strabismes Concomitants

Dr Camilia Chafter | Orthoptie – Cours Strabisme

1. Introduction et objectifs

Les strabismes concomitants représentent une part importante de l'activité orthoptique et nécessitent une approche clinique rigoureuse ainsi qu'une prise en charge précoce.

Objectifs du cours :

- Définir précisément un strabisme concomitant.
- Reconnaître les différentes formes cliniques.
- Réaliser un examen orthoptique complet et interpréter ses résultats.
- Participer à la prise en charge thérapeutique adaptée à chaque situation.

2. Rappel : Concomitant vs Incomitant

Caractéristique	Strabisme concomitant	Strabisme incomitant
Angle de déviation	Constant quelle que soit la direction	Variable selon la direction du regard
Motilité oculaire	Conservée	Limitation ou restriction musculaire
Mécanisme principal	Déséquilibre du contrôle binoculaire	Paralysie ou restriction musculaire

3. Définition

- L'angle de déviation reste **constant dans toutes les directions du regard**.
- La motilité oculaire est **conservée** (pas de limitation des mouvements).
- Il traduit principalement un **déséquilibre du contrôle binoculaire**, et non une atteinte musculaire ou neurologique.

4. Physiopathologie

Facteur	Mécanisme
Défaut de fusion binoculaire	Incapacité à maintenir l'alignement des yeux
Anomalies de réfraction (hypermétropie)	Hyperactivité accommodative → convergence excessive
Facteurs génétiques et développementaux	Peuvent intervenir dans l'apparition du trouble

5. Conséquences sensorielles

Chez l'enfant, la diplopie est rarement ressentie car le cerveau met en place des mécanismes d'adaptation :

Mécanisme	Description	Conséquence
Suppression	Le cerveau supprime l'image de l'œil dévié pour éviter la confusion visuelle	Peut évoluer vers l'amblyopie

Mécanisme	Description	Conséquence
Amblyopie	Conséquence à long terme d'une suppression prolongée	Baisse de l'AV de l'œil non utilisé
CRA (Correspondance Rétinienne Anormale)	Modification de la perception de l'espace visuel	Altération de la stéréoscopie

6. Classification des strabismes concomitants

Critère de classification	Types
Direction de la déviation	Ésotropie (vers l'intérieur) / Exotropie (vers l'extérieur)
Mode d'apparition	Constant / Intermittent
Âge de survenue	Infantile (précoce, avant 6 mois) / Acquis (après 6 mois)

7. Rôle de l'orthoptiste

L'orthoptiste joue un rôle central à toutes les étapes :

- Dépistage et suivi après traitement.
- Mesures précises de la déviation.
- Évaluation des fonctions sensorielles.
- Mise en place de la rééducation visant à améliorer la vision binoculaire.

8. Examen orthoptique

8.1 Interrogatoire

- Âge d'apparition du strabisme et mode d'installation.
- Caractère permanent ou intermittent.
- Présence de diplopie ou de signes fonctionnels associés.
- Antécédents familiaux de strabisme ou d'amblyopie.

8.2 Inspection

- Position de la tête (torticolis compensateur éventuel).
- Qualité de la fixation.
- Présence d'un clignement excessif ou fermeture d'un œil.
- Dominance oculaire.

8.3 Cover test

Examen clinique fondamental permettant de mettre en évidence une déviation manifeste ou latente.

Type de cover test	Principe	Ce qu'il révèle
Cover test simple	Occlusion d'un œil pendant que l'autre fixe → observation du mouvement de refixation	Révèle la tropie (strabisme manifeste)
Cover test alterné	Occlusion alternative de chaque œil pour dissocier	Mesure l'angle total de la déviation

8.4 Mesure de l'angle de déviation

- Prismes placés devant l'œil pour neutraliser le mouvement de refixation.

- Mesure de **loin et de près** pour détecter des variations.
- Le **synoptophore** permet d'affiner la mesure et d'analyser les capacités de fusion.

8.5 Étude sensorielle

- Évaluation de la stéréoscopie (tests spécifiques : Wirt, Titmus, TNO).
- Permet de déterminer le potentiel de récupération fonctionnelle.

8.6 Réfraction (sous cycloplégie)

- Obligatoire chez l'enfant pour une mesure fiable.
- Recherche d'hypermétropie (directement impliquée dans la genèse de l'ésotropie accommodative).
- La correction optique constitue souvent la **première étape du traitement**.

9. Types de strabismes concomitants

9.1 Ésotropies

Forme	Âge d'apparition	Caractéristiques	Traitement
Ésotropie infantile	Avant 6 mois	Angle important et constant ; alternance possible ; vision binoculaire absente ou très altérée ; nystagmus latent, hyperaction des obliques inférieurs	Souvent chirurgical après traitement de l'amblyopie
Ésotropie accommodative pure	2–4 ans	Liée à une hypermétropie non corrigée ; déviation disparaît complètement avec la correction optique	Port permanent de lunettes
Ésotropie partiellement accommodative	Variable	La correction optique réduit l'angle mais ne l'élimine pas entièrement	Lunettes + amblyopie + chirurgie si nécessaire

9.2 Exotropies

Forme	Caractéristiques	Prise en charge
Exotropie (générale)	Déviation des axes visuels vers l'extérieur ; souvent intermittente au début ; vision binoculaire partiellement conservée	Selon fréquence et retentissement
Exotropie intermittente (forme la plus fréquente)	Visible lors de fatigue, inattention, fixation au loin, forte luminosité ; fermeture d'un œil au soleil	Surveillance → rééducation → chirurgie

9.3 Microstrabisme

- Déviation de faible amplitude (< 10 dioptries prismatiques).
- Passe souvent inaperçu à l'inspection simple.
- Fréquemment associé à une amblyopie modérée et une CRA.
- Vision binoculaire altérée mais partiellement conservée (fusion périphérique possible).
- Diagnostic : test de Lang, test de fixation excentrée.

9.4 Strabisme sensoriel

- Secondaire à une **baisse de vision unilatérale** (quelle qu'en soit la cause).
- La mauvaise qualité de l'image empêche le maintien de l'alignement.

- Peut être ésoptropie ou exotropie.
- Traitement : traiter la cause visuelle en priorité, puis corriger la déviation si nécessaire.

10. Traitement des strabismes concomitants

10.1 Objectifs généraux

1. Obtenir un bon alignement oculaire.
2. Prévenir ou traiter l'amblyopie (**priorité urgente**).
3. Favoriser le développement ou la restauration de la vision binoculaire.

10.2 Correction optique

- Première étape du traitement, surtout dans les ésootropies accommodatives.
- Port **constant** de lunettes prescrites après réfraction sous cycloplégie.
- Peut suffire à réaligner les axes visuels dans les formes purement accommodatives.

10.3 Traitement de l'amblyopie

- **Occlusion de l'œil dominant** pour stimuler l'œil amblyope.
- Alternatives : pénalisation optique ou pharmacologique.
- L'efficacité dépend de la **précocité** et de l'observance.

10.4 Rééducation orthoptique

- Objectif : améliorer les capacités de fusion et renforcer le contrôle de la déviation.
- Exercices de convergence, divergence et coordination binoculaire.
- Particulièrement utile dans les exotropies intermittentes et les troubles de la convergence.

10.5 Traitement chirurgical

- Indiqué en cas de déviation persistante malgré une prise en charge bien conduite.
- Techniques : recul (affaiblissement) ou résection (renforcement) des muscles oculomoteurs.
- Objectif : réaligner les axes visuels (amélioration fonctionnelle et esthétique).
- Ne dispense pas d'un suivi orthoptique post-opératoire.

11. Suivi

- Doit être **régulier et prolongé**.
- Surveillance de l'évolution de la déviation, de l'efficacité du traitement et du développement de la vision binoculaire.
- Des ajustements thérapeutiques sont souvent nécessaires.

12. Cas cliniques

Cas 1 : Ésoptropie accommodative avec amblyopie

Enfant de 3 ans, déviation convergente constante apparue progressivement. Hypermétropie importante + amblyopie de l'œil droit.

CAT : Prescrire la correction optique adaptée + débiter le traitement de l'amblyopie. Réévaluation pour juger de la part accommodative.

Cas 2 : Exotropie intermittente

Enfant avec exotropie visible en fin de journée et en vision de loin. Contrôle encore partiellement conservé.

CAT : Surveillance + rééducation orthoptique en première intention. Indication chirurgicale à discuter en cas d'aggravation ou de perte de contrôle.

13. Pièges diagnostiques à éviter

Piège	Risque	À faire
Ne pas méconnaître un strabisme incomitant	Peut traduire une atteinte neurologique grave	Examen moteur complet dans les 9 directions
Réfraction incomplète	Erreur diagnostique (surtout ésoptropie accommodative)	Réfraction obligatoire sous cycloplégie
Amblyopie non recherchée	Peut passer inaperçue et s'aggraver	Tester systématiquement l'AV de chaque œil